

KESEHATAN REPRODUKSI BAGI CALON PENGANTIN



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2020**

KESEHATAN REPRODUKSI BAGI CALON PENGANTIN

613.94
Ind
k

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jendral
Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin.-

Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2018

ISBN 978-602-416-429-4

1. Judul I. REPRODUCTION

II. ADOLESCENT HEALTH SERVICES

Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin

Kementerian Kesehatan RI

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Direktorat Kesehatan Keluarga

Sub Direktorat Kesehatan Usia Reproduksi

Pengarah: Direktur Kesehatan Keluarga

Editor : Sub Direktorat Kesehatan Usia Reproduksi

Kontributor :

1. Direktorat Kesehatan Keluarga
2. Direktorat Gizi Masyarakat
3. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
4. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
5. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
6. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
7. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung



Hak Cipta dilindungi Undang-undang dilarang memperbanyak dan menterjemahkan sebagian seluruh isi tanpa seizin tertulis dari penerbit Kementerian Kesehatan RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karuniaNya, sehingga buku saku "Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin" yang telah disusun dan dipergunakan sejak tahun 2009 ini dapat direvisi dan dicetak kembali untuk memenuhi kebutuhan informasi kesehatan masyarakat yang semakin berkembang.

Buku saku ini disusun untuk melengkapi Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin sebagai media KIE di fasilitas pelayanan kesehatan. Diharapkan buku saku ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh calon pengantin sehingga mendapatkan informasi kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif, termasuk bagaimana merencanakan dan mempersiapkan kehamilan yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Kami menyadari bahwa buku saku ini masih perlu untuk terus disempunakan sesuai dengan perkembangan program dan ilmu kesehatan. Oleh karena itu, segala masukan dalam rangka perbaikan buku ini, akan sangat kami hargai dan harapkan.

Jakarta, Juni 2018

Direktur Kesehatan Keluarga,



dr. Eni Gustina, MPH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB 1 FILOSOFI PERNIKAHAN	8
BAB 2 INFORMASI KESEHATAN PRANIKAH	10
A. Kesehatan Reproduksi	10
B. Hak Reproduksi	12
C. Organ Reproduksi	14
1. Organ Reproduksi Perempuan	14
2. Organ Reproduksi Laki-Laki	17
D. Persiapan Kesehatan Pranikah	19
A. Persiapan Fisik	19
B. Imunisasi Tetanus	20
C. Persiapan Gizi	21
D. Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi	25
BAB 3 INFORMASI TENTANG KEHAMILAN DAN KONTRASEPSI	26
A. Kehamilan	26
1. Masa Subur	26
2. Perempuan Layak Hamil	28
3. Proses Kehamilan	30
4. Tanda-Tanda Kehamilan	32
5. Kehamilan Ideal vs Kehamilan Tidak Direncanakan	33
6. Kondisi Emosional Ibu Hamil	35
B. Pilihan Metode Kontrasepsi Bagi Pasangan Baru yang Ingin Menunda Kehamilan	36
BAB 4 KONDISI KESEHATAN YANG PERLU DIWASPADAI OLEH PASANGAN CALON PENGANTIN	38
A. Anemia	38
B. Kekurangan Gizi	40
C. Infertilitas	41
D. Hepatitis B	43
E. Diabetes Melitus	46
F. Malaria	48

G. TORCH	49
H. Thalassemia	51
I. Hemofilia	54
J. Infeksi Menular Seksual (IMS)	56
K. HIV-AIDS	64
L. Infeksi Saluran Reproduksi (ISR)	67
BAB 5 KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM	71
A. Kanker Payudara	71
B. Kanker Leher Rahim	77
BAB 6 KEHIDUPAN SEKSUAL SUAMI ISTRI.....	79
A. Gangguan Seksual Pada Perempuan	80
B. Gangguan seksual pada Laki-laki	81
C. Mencegah Gangguan Seksual.....	81
BAB 7 Menjaga Kesehatan Jiwa dan Harmonisasi Pasangan Suami Istri	83
BAB 8 KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA	85
A. Saling Menghormati dan Menghargai	85
B. Tindak Kekerasan yang Mengganggu Pernikahan	86
C. Solusi Mengatasi Tindak Kekerasan.....	87
BAB 9 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)	89

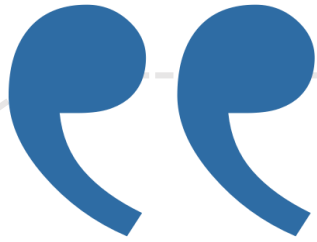
BAB 1

FILOSOFI PERNIKAHAN

Akad/janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*).

Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa dalam akad / janji pernikahan berarti bahwa disamping saling bertanggungjawab antara satu dengan yang lain, suami istri juga bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang dilakukan dalam peran dan fungsi mereka sebagai suami istri.



A large, blue, stylized opening quotation mark.

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga sehingga sebelum menikah **catin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya** agar melahirkan generasi penerus yang sehat dan keluarga bahagia

A large, blue, stylized closing quotation mark.

BAB 2

INFORMASI KESEHATAN PRANIKAH

A. Kesehatan Reproduksi

Dalam melakukan peran sebagai pasangan, suami dan istri haruslah memiliki kesehatan lahir dan batin yang baik. Salah satu indikasi calon pengantin sehat adalah kondisi kesehatan reproduksinya baik.

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.

Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia, misalnya masalah pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas, serta penyakit menular seksual.

Pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan terutama dalam isu-isu kesehatan reproduksi. Namun keterlibatan, motivasi, serta partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi masih rendah.

Perempuan lebih rentan dalam menghadapi risiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, pemakaian alat

kontrasepsi dan aborsi yang tidak aman. Selain itu perempuan juga lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan IMS, termasuk HIV AIDS karena struktur alat reproduksinya dan lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan atau perlakuan kasar akibat subordinasi perempuan terhadap laki-laki atau hubungan gender yang tidak setara.

Status kesehatan reproduksi laki-laki sangat mempengaruhi status kesehatan pasangannya. Laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan reproduksi, khususnya yang berkaitan dengan IMS termasuk HIV AIDS.



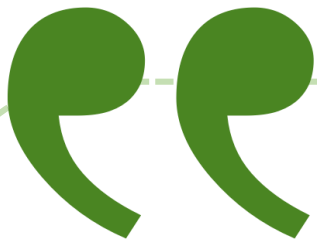
B. Hak Reproduksi

Kedua calon pengantin mempunyai kebebasan, hak dan tanggungjawab yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran.

Hak reproduksi harus menjamin keselamatan dan keamanan calon pengantin, termasuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Informasi ini meliputi penyakit menular seksual dan pencegahannya agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual (IMS) dan infeksi saluran reproduksi (ISR) yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki, perempuan, dan keturunannya, memahami upaya pencegahan dan penularannya, serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi.

Calon pengantin juga berhak untuk memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima, sesuai dengan pilihan tanpa paksaan.

Pihak perempuan berhak mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat.

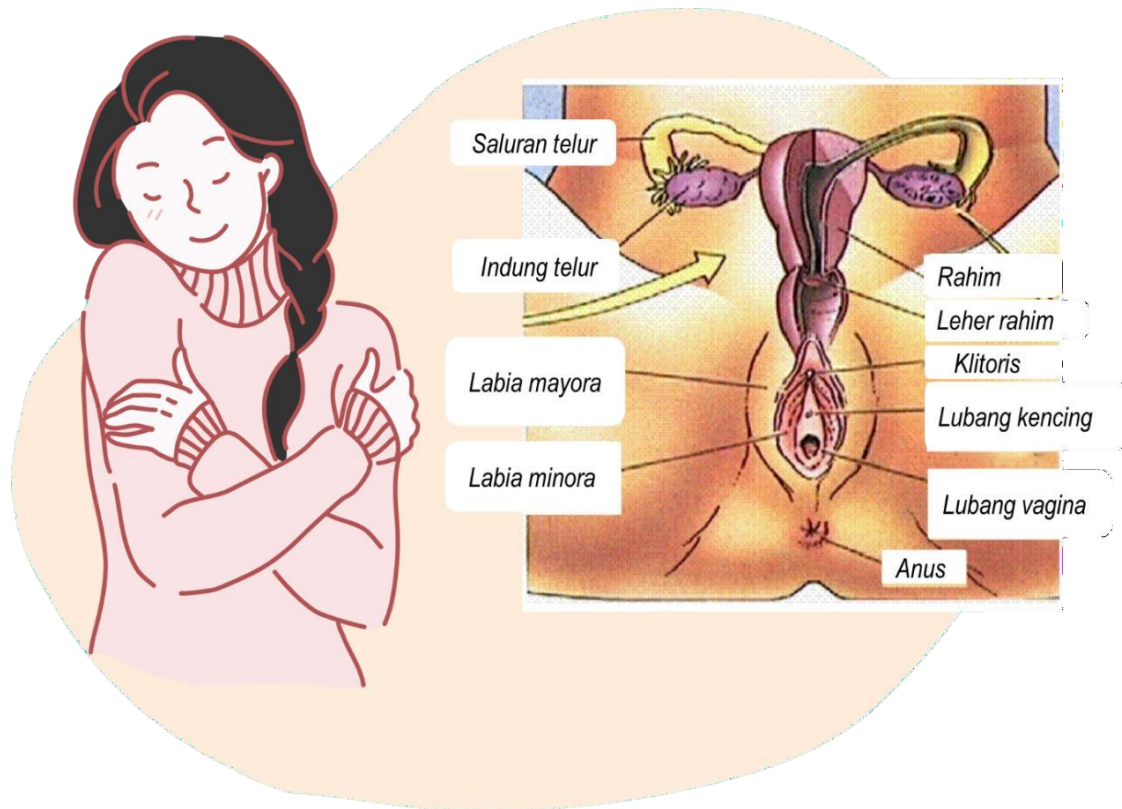


Hubungan suami istri harus didasari
penghargaan terhadap pasangan
masing-masing dan dilakukan dalam
kondisi yang diinginkan bersama tanpa
unsur pemaksaan,
ancaman dan kekerasan



C. Organ Reproduksi

1. Organ Reproduksi Perempuan



Gambar 1: Organ Reproduksi Perempuan

Organ reproduksi perempuan terdiri dari:

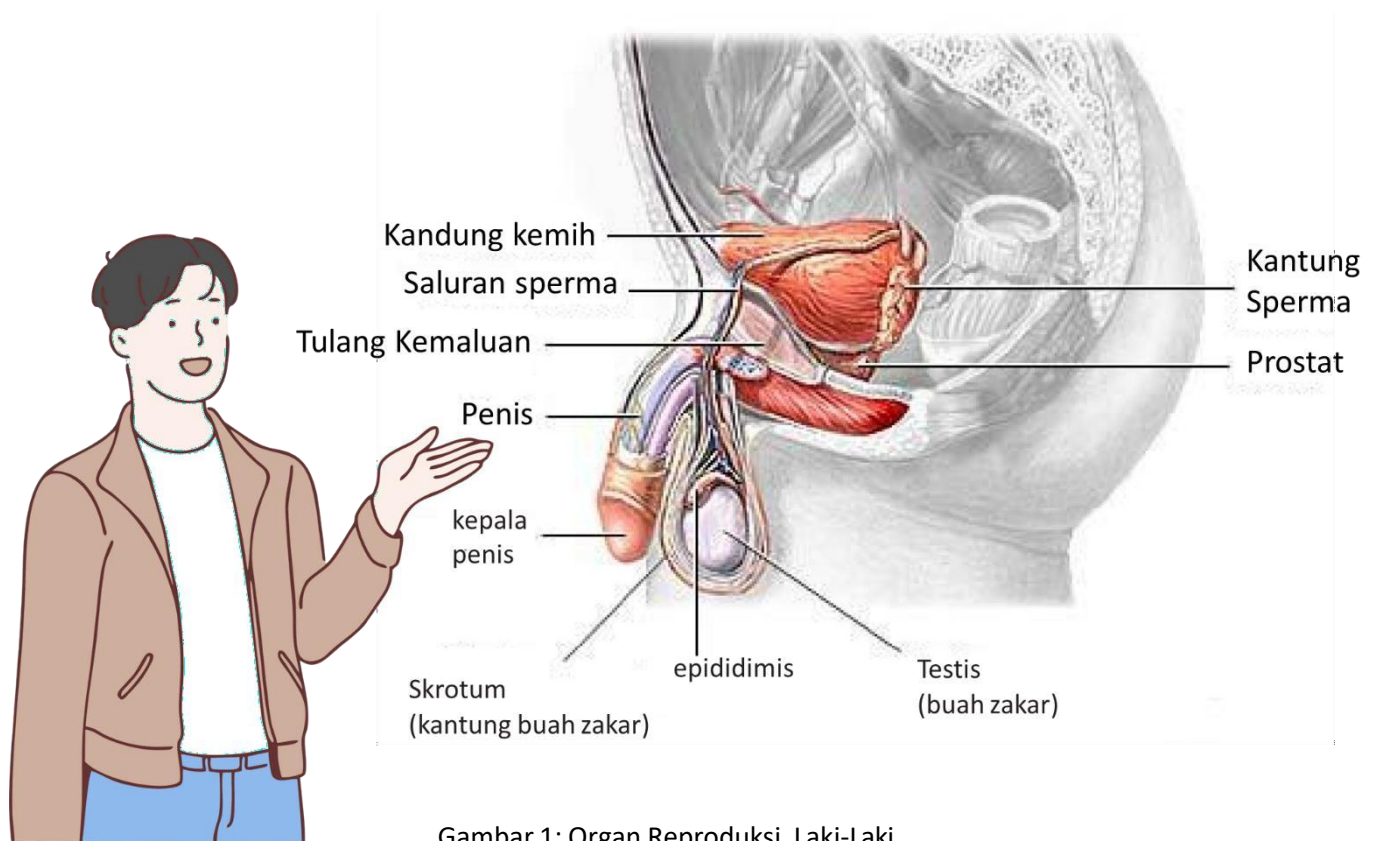
- a. **Ovarium (Indung Telur):** Organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur (fimbriae/umbai-umbai) dan terletak di rongga pinggul. Indung telur berfungsi mengeluarkan sel telur (ovum), sebulan sekali indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Sel

telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma sehingga terjadi konsepsi (pembuahan). Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi.

- b. **Tuba Fallopii (saluran telur).** Saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk mengantar ovum dari indung telur menuju rahim.
- c. **Fimbriae (umbai-umbai).** Berfungsi menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. untuk
- d. **Uterus (rahim).** Merupakan tempat janin berkembang, bentuknya seperti buah pir dan berat normalnya antara 30-50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung, dindingnya terdiri dari:
 - a. *Lapisan parametrium merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut.*
 - b. *Lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan (kontraksi).*
 - c. *Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah.*

- e. **Serviks (leher rahim).** Bagian rahim yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar.
- f. **Vagina (liang kemaluan).** Merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan 6,5 cm dan dinding belakang 19 cm yang bersifat elastis dengan berlipat lipatan. Fungsinya sebagai tempat penis berada
- g. **Klitoris (kelentit).** Merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibandingkan dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lain. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf.
- h. **Labia (bibir kemaluan).** Terdiri dari dua bibir, yaitu bibir besar (labia mayor) dan bibir kecil (labia minor).
- i. **Perineum,** merupakan jaringan di antara vagina dan anus, yang memisahkan rongga panggul atas dengan rongga panggul bawah. Perineum berperan penting dalam berkemih, buang air besar, hubungan seksual, dan melahirkan.

2. Organ Reproduksi Laki-Laki



Organ reproduksi laki-laki terdiri dari:

- a. **Testis (buah zakar).** Berjumlah dua buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Testis berada dalam skrotum, diluar rongga panggul karena pembentukan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah dari pada suhu badan ($36,7^{\circ}\text{C}$). Sperma merupakan sel yang berbentuk seperti berudu (kecebong) hasil dari testis yang dikeluarkan saat ejakulasi bersama cairan mani dan bila bertemu dengan sel telur yang matang akan terjadi pembuahan.

- b. **Skrotum (kantong buah zakar).** Kantong kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan berlipat lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap.
- c. **Vas deferens (saluran sperma).** Saluran yang menyalurkan sperma dari testis-epididimis menuju ke uretral saluran kencing pars prostatika. Vas deferens panjangnya 14,5 cm dengan diameter +2,5 mm. Saluran ini muara dari Epididimis yaitu saluran- saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi
- d. **Prostat, vesikula seminalis** dan beberapa kelenjar lainnya. Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani (semen) yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma.
- e. **Penis.** Berfungsi sebagai alat untuk berhubungan seksual dan sebagai saluran pengeluaran sperma dan air seni. Pada keadaan biasa, ukuran penis kecil. Ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke penis sehingga berubah menjadi tegang dan besar disebut sebagai ereksi. Bagian glans merupakan bagian depan atau kepala penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Kulit yang menutupi glans disebut foreskin (preputium). Pada laki-laki sunat dilakukan dengan cara membuang kulit preputium. Secara medis sunat dianjurkan karena

memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi, radang dan kanker.

D. Persiapan Kesehatan Pranikah

A. Persiapan Fisik

Dalam rangka mempersiapkan kesehatan sebelum menikah, calon perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan, antara lain:

a) Pemeriksaan tanda-tanda vital: suhu, nadi, frekuensi nafas, tekanan darah.

b) Pemeriksaan status gizi:

- Berat badan
- Tinggi badan
- Lingkar lengan atas (LILA)
- Tanda-tanda Anemia/kekurangan darah

c) Pemeriksaan Laboratorium

- Pemeriksaan darah rutin: Hb, golongan darah dan rhesus
- Pemeriksaan urin rutin
- Pemeriksaan lain atas indikasi seperti: Gula darah, IMS, HIV, Malaria, Thalassemia, Hepatitis B, TORCH (toksoplasmosis, rubella, citomegalovirus dan herpes simpleks), dsb.

B. Imunisasi Tetanus

- Imunisasi Td untuk WUS (Wanita Usia Subur) termasuk ibu hamil dan catin, merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit Tetanus dan Difteri.
- Catin perempuan perlu mendapat imunisasi Tetanus agar memiliki kekebalan saat hamil dan melahirkan, ibu dan bayi akan terlindungi dari penyakit Tetanus.
- Tiap WUS (15-49 tahun) diharapkan sudah mendapat 5 kali imunisasi Tetanus lengkap (T5).
- Jika status T belum lengkap, maka catin perempuan harus melengkapi status imunisasi Tetanusnya di Puskesmas.
- Sebelum Imunisasi, dilakukan penentuan status imunisasi Tetanus (status T) melalui skrining. Jika status T belum lengkap, maka catin perempuan harus melengkapinya di Puskesmas.
- Pemberian imunisasi Tetanus tidak perlu diberikan, jika status T sudah mencapai T5, yang harus dibuktikan dengan catatan yang terkait antara lain pada Kartu Imunisasi, buku Kesehatan Ibu dan Anak, buku Rapor Kesehatanku, kohort dan / atau rekam medis lainnya.

Status Imunisasi Tetanus pada Catin

Status Imunisasi Tetanus pada Catin

Status Imunisasi	Interval Minimal Pemberian	Masa Perlindungan
T1	-	-
T2	4 minggu setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	1 tahun setelah T3	10 tahun
T5	1 tahun setelah T4	Lebih dari 25 tahun

Imunisasi Tetanus pada catin perempuan penting untuk mencegah dan melindungi dari penyakit Tetanus baik bagi diri sendiri maupun bayi yang akan dilahirkan kelak.

C. Persiapan Gizi

Status gizi catin perempuan perlu diketahui dalam rangka persiapan kehamilan.

- 1) Status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT). Untuk catin perempuan ditambah dengan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA).
- 2) IMT merupakan proporsi standar berat badan (BB) terhadap tinggi badan (TB).

- 3) Pengukuran LiLA bertujuan untuk mengetahui adanya risiko Kurang Energi Kronik (KEK). Ambang batas.
- 4) LiLA pada WUS dengan KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila LiLA kurang dari 23,5 cm (bagian merah pita LiLA), artinya catin perempuan mengalami KEK.

Cara menghitung IMT:

$$IMT = \frac{BB \text{ (kg)}}{TB \text{ (m)}^2}$$

Keterangan:

BB = Berat Badan (kg)

TB = Tinggi Badan (m)

Tabel Klasifikasi Nilai IMT

Status Gizi	Kategori	IMT
Sangat kurus	Kekurangan BB tingkat berat	< 17,0
Kurus	Kekurangan BB tingkat ringan	17 - < 18,5
Normal		18,5 – 25,0
Gemuk	Kelebihan BB tingkat ringan	> 25,0 – 27,0
Obesitas	Kelebihan BB tingkat berat	> 27,0

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, catin perlu melakukan persiapan gizi antara lain:

- Setiap pasangan catin dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.
- Setiap catin perempuan dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) yang mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali.
- Bagi catin perempuan yang mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) dan Anemia maka perlu ditentukan penyebabnya dan ditatalaksana sesuai dengan penyebab tersebut di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Untuk mendapatkan masukan gizi yang seimbang ke dalam tubuh, catin perlu mengonsumsi lima kelompok makanan yang beraneka ragam setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok makanan tersebut adalah lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Proporsinya dalam setiap kali makan dapat digambarkan dalam ISI PIRINGKU yaitu:
 - ✓ Sepertiga piring berisi makanan pokok
 - ✓ Sepertiga piring berisi sayuran
 - ✓ Sepertiga piring berisi lauk pauk dan buah-buahan dalam piring yang sama
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan agar tetap sehat:

- ✓ Biasakan minum air putih 8 gelas per hari
- ✓ Hindari minum teh atau kopi setelah makan
- ✓ Batasi mengonsumsi garam, gula, lemak / minyak



Berikut ini adalah 4 pilar gizi yang dapat digunakan untuk gaya hidup sehat.



D. Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi

Organ reproduksi perlu dijaga kesehatannya agar dapat berfungsi dengan baik. Beberapa tips untuk menjaga kesehatan organ reproduksi antara lain:

- Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari.
- Gunakan pakaian dalam berbahan sintetis (katun) yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat.
- Bersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu.
- Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab/bau. Khusus untuk perempuan:
 - Tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina.
 - Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama.
 - Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air.
 - Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan.
- Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat.

BAB 3

INFORMASI TENTANG KEHAMILAN DAN KONTRASEPSI

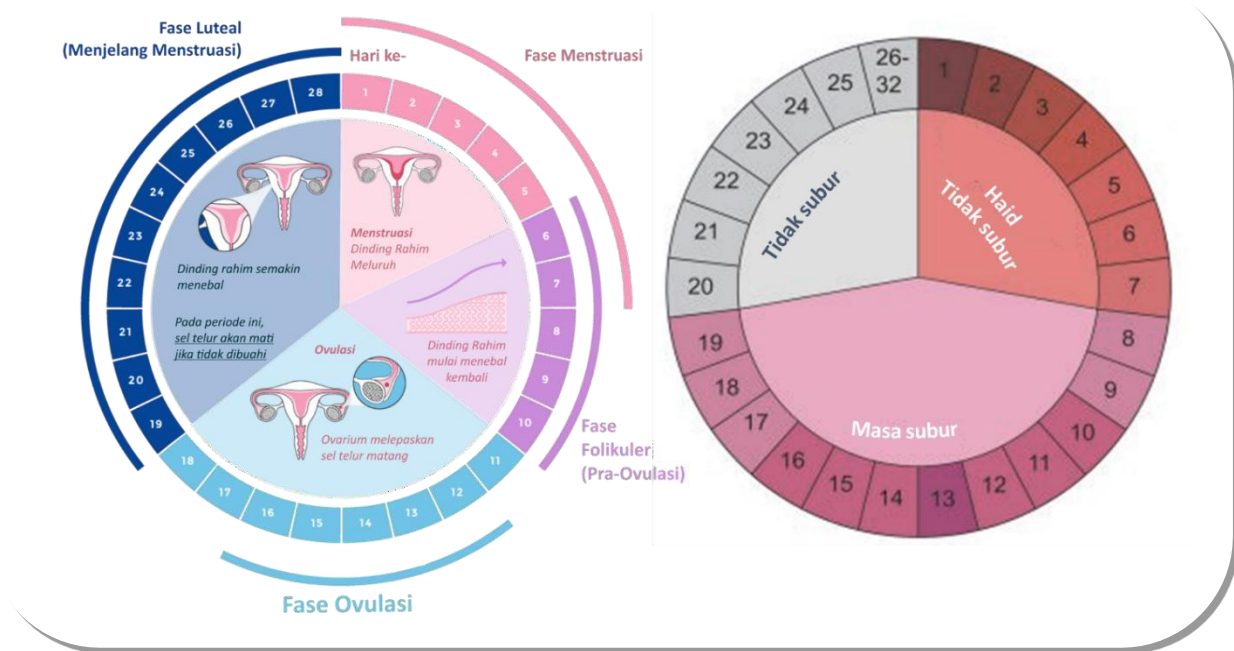
A. Kehamilan

1. Masa Subur

Masa subur adalah saat indung telur (ovarium) melepaskan sel telur (ovum) yang sudah siap dibuahi ke dalam saluran indung telur (tuba fallopi). Masa subur adalah periode dalam siklus menstruasi dimana konsepsi atau fertilisasi (pembuahan) paling mungkin terjadi, karena pada periode tersebut terdapat sel telur yang matang dan siap dibuahi.

- Masa subur dapat diketahui dengan cara menghitung ovulasi/masa subur pada wanita.
- Puncak masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah hari pertama haid, sedangkan masa subur biasa akan terjadi kurang lebih tiga hari sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur tersebut.

Siklus Menstruasi



Tanda-tanda masa subur:

- Perubahan lendir serviks Pada masa subur, cairan ini bertekstur lengket dan kental. Perubahan terjadi menjelang masa subur, yaitu dengan meningkatnya jumlah cairan dan perubahan tekstur menjadi berwarna bening dan lebih cair.
- Dorongan seksual meningkat Hormon estrogen dan progesteron akan meningkat dalam masa subur sehingga meningkatkan hasrat seksual.
- Temperatur tubuh meningkat dan payudara lebih lunak Meningkatnya hormon progesteron ketika masa subur

akan memicu kenaikan suhu tubuh (+ 0,5°C) dan menyebabkan payudara menjadi lebih lunak.

2. Perempuan Layak Hamil

Seorang perempuan layak untuk hamil apabila:

a. UMUR

Ideal : 20-34 tahun

Jika:

- Usia < 20 tahun: tunda kehamilan
- Usia > 35 tahun:
 - Jumlah anak 1 orang –dibawah pengawasan khusus
 - Jumlah anak ≥ 3 orang –dianjurkan tidak hamil lagi

b. JUMLAH ANAK

Ideal : < 3 orang

Jika: ≥ 3 orang : dianjurkan tidak hamil lagi

c. JARAK KEHAMILAN

Ideal : > 2 tahun

Jika: < 2 tahun: tunda kehamilan sampai usia anak 2 tahun

d. IMT

Ideal : 18,5 –25,0 (normal)

Jika:

- < 18,5 (KEK): tunda kehamilan sampai mencapai BB normal, diet tinggi kalori dan protein, minum obat cacing
- > 25,0 –27,0 (kelebihan BB tingkat ringan)

- > 27,0 (kelebihan BB tingkat berat/obesitas)

e. KONDISI KESEHATAN

Ideal : Tidak mempunyai masalah kesehatan

Jika mempunyai masalah kesehatan: tunda kehamilan dan anjuran ditatalaksana sampai sembuh atau terkontrol dibawah pengawasan

KONDISI KESEHATAN YANG DIPERHATIKAN

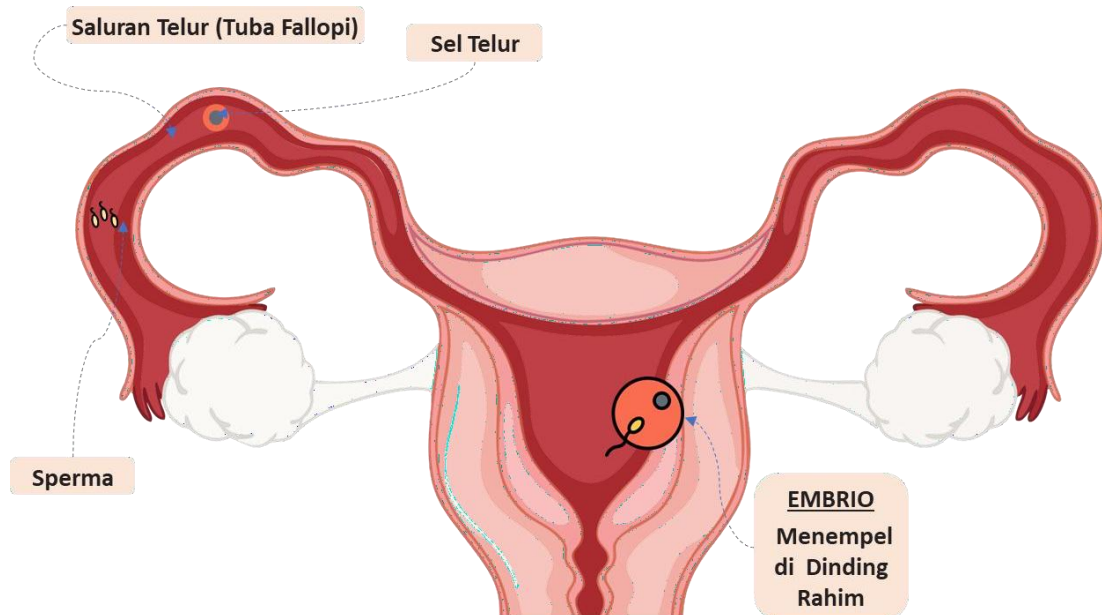
- Hb
- Penyakit menular(HIV, Sifilis, Hepatitis, TB, malaria, kecacingan dll)
- Penyakit tidak menular(DM, Hipertensi, Jantung, auto imun, kanker, stroke, dll)
- Kesehatan Jiwa
- Penyakit genetik: Talasemia, Hemofilia

"Rencanakan kehamilan dengan baik bersama pasangan.

Setiap kehamilan harus direncanakan dan diinginkan serta dijaga agar ibu dan bayi sehat dan selamat."



3. Proses Kehamilan



Sel telur yang matang
dibuahi oleh sperma dalam
saluran telur (tuba fallopi)



Sel telur yang telah dibuahi
sperma (embrio) menempel di
lapisan dalam dinding rahim



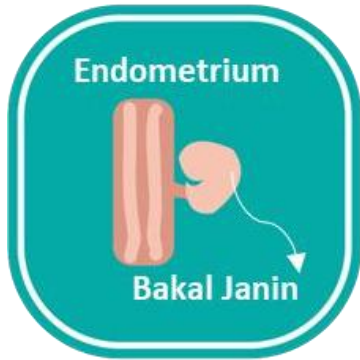
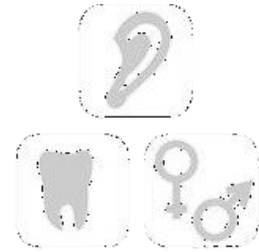
Dalam 120 hari pertama, embrio
berkembang mengikuti tahapan
kehidupan sel (hayati)



Kehamilan umumnya berakhir
dengan persalinan setelah 280
hari (9 bulan 10 hari)



Memasuki usia kehamilan lebih
lanjut, embrio berkembang
mengikuti tahapan kehidupan
insani menjadi janin/ bayi



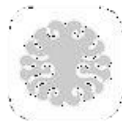
**1 Minggu
(7 Hari)**



**4 Minggu
(28 Hari)**



**8 Minggu
(56 Hari)**



**12 Minggu
(84 Hari)**



**24 Minggu
(168 Hari)**

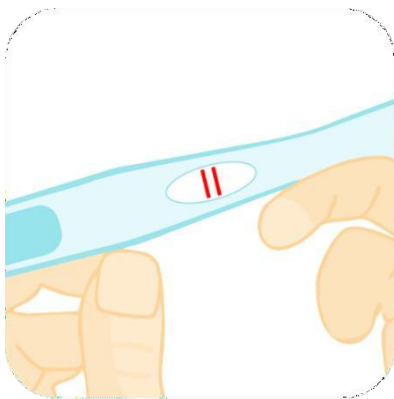


**40 Minggu
(280 Hari)**

4. Tanda-Tanda Kehamilan

Terdapat beberapa tanda-tanda kehamilan, antara lain:

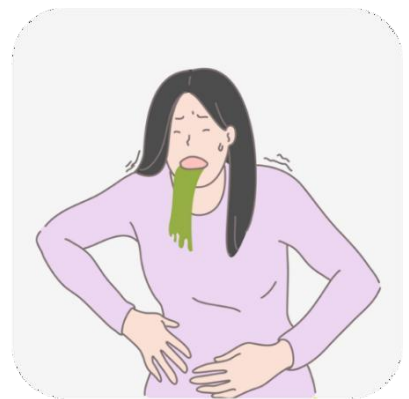
- Tidak mendapat menstruasi/ haid sebagaimana biasanya (tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya)
- Timbul rasa mual, muntah-muntah dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil
- Tidak ada nafsu makan
- Tes kehamilan positif (+)
- Pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin
- Perut membesar dan dirasakan gerakan janin



TES KEHAMILAN POSITIF



TIDAK NAFSU MAKAN



MUAL & MUNTAH-MUNTAH



Jika sudah terdapat tanda-tanda kehamilan segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Setiap ibu hamil akan diberikan Buku KIA.

- **Catatan : gambar orang muntah lebih dibagusin lagi**

5. Kehamilan Ideal vs Kehamilan Tidak Direncanakan

Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik. Namun ada kalanya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan seperti:

- Akibat hubungan seks pranikah
- Pada unmet need ber-KB (wanita usia subur yang ingin menunda atau tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan kontrasepsi)
- Akibat gagal KB

Usia terbaik perempuan untuk hamil adalah antara 20-35 tahun dan jarak antar kelahiran idealnya 3-5 tahun atau tidak lebih dari 2 balita dalam satu keluarga. Adanya jarak kelahiran tersebut akan memberi kesempatan kepada ibu untuk memulihkan kembali kesehatan tubuhnya serta memberi kesempatan bagi anak yang dilahirkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari orangtuanya.

Apabila merencanakan punya anak lagi, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai biaya perawatan, pendidikan dan kehidupan yang layak termasuk pemenuhan gizinya.

Walaupun demikian, setiap kehamilan tetap harus dijaga dan dipantau kesehatan dan perkembangannya.

Setiap kehamilan mempunyai risiko untuk terjadi komplikasi walaupun sebelumnya baik-baik saja. Sebagai contoh, saat hamil kondisi ibu dan bayi sehat, namun saat persalinan ibu dapat mengalami perdarahan hebat atau bayi mengalami sesak nafas (asfiksia).

Suami dianjurkan untuk mendampingi bu hamil saat memeriksakan kehamilannya.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan yang disebut dengan **4 Terlalu dan 3 Terlambat**.

4 (EMPAT) TERLALU yaitu:

1. Terlalu muda untuk hamil (kurang dari 20 tahun)
2. Terlalu tua untuk hamil (lebih dari 35 tahun)
3. Terlalu sering hamil (anak lebih dari 3)
4. Terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya (kurang dari 2 tahun)

3 (TIGA) TERLAMBAT yaitu:

1. Terlambat mengenali tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas, serta mengambil keputusan untuk mencari pertolongan medis

2. Terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat



Hindari 4 Terlalu dan 3 Terlambat
untuk mengurangi risiko
terjadinya komplikasi pada
kehamilan dan persalinan

6. Kondisi Emosional Ibu Hamil

Setiap kehamilan perlu didukung oleh suami dan keluarga. Perlu persiapan fisik, sosial dan ekonomi yang baik dalam menyambut kelahiran. Hal ini dapat mendukung terjaganya kondisi emosional ibu hamil. Ibu hamil juga tidak boleh dibebani dengan pikiran dan pekerjaan yang berat atau tugas yang banyak.

Berikut kondisi emosional yang biasa dialami oleh ibu hamil:

- Mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, tidak semangat.
- Perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Hal-hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisiknya.

- Mencemaskan perubahan fisiknya, khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal atau cacat.
- Merasa belum siap menjadi orangtua dan belum siap secara ekonomi.
- Ingin diperhatikan, pada waktu mengidam menginginkan makanan-makanan yang mungkin tidak pada musimnya sehingga sulit didapat. Hal tersebut semata-mata karena ingin diperhatikan keluarga dan suami.



Ibu hamil harus mendapat dukungan dari suami dan keluarga agar dapat menjalani kehamilan yang sehat

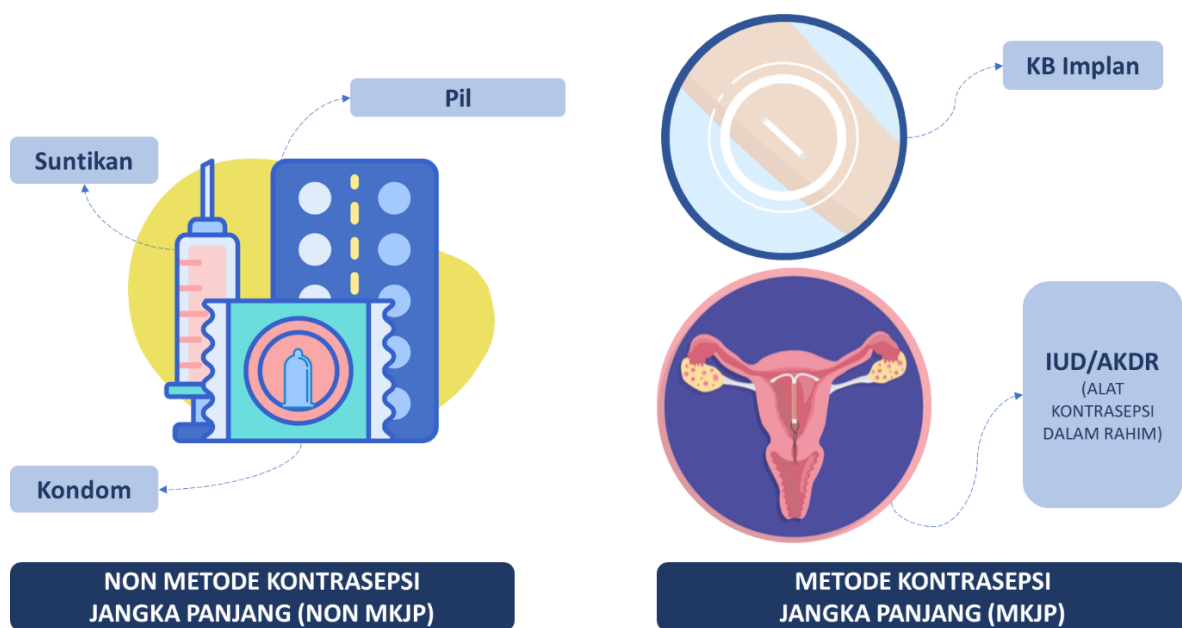


B. Pilihan Metode Kontrasepsi Bagi Pasangan Baru yang Ingin Menunda Kehamilan

Bagi pasangan yang belum ingin segera memiliki anak atau istri berusia kurang dari 20 tahun, dapat menunda kehamilan dengan

menggunakan salah satu metode KB yang sesuai. Pasangan dianjurkan untuk berkonsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gambar berikut adalah pilihan metode KB bagi pasangan suami istri yang baru menikah dan ingin menunda kehamilan.

Metode Kontrasepsi



BAB 4

KONDISI KESEHATAN YANG PERLU DIWASPADAI OLEH PASANGAN CALON PENGANTIN

A. Anemia

Anemia adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah kurang dari normal (12 mg/dL). Sekitar 1 dari 5 wanita usia subur (WUS) di Indonesia menderita kekurangan darah (Anemia). Anemia dapat menimbulkan risiko pada kehamilan dan persalinan.

Anemia sering dialami oleh perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, gangguan haid/haid abnormal, dan penyakit lainnya (seperti kecacingan, Malaria, dan lainnya).

Tanda Anemia antara lain:

- Lesu, Letih, Lemah, Lelah, Lunglai (5L)
- Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang

Ibu hamil dikatakan Anemia apabila Hb <11 mg/dL.

Dampak Anemia pada ibu hamil adalah:

- Pertumbuhan janin terhambat
- Bayi berat lahir rendah (BBLR)
- Bayi lahir sebelum waktunya (prematur)
- Bayi mengalami kelainan bawaan
- Anemia pada bayi yang dilahirkan
- Risiko perdarahan saat melahirkan

Anemia dapat dicegah dan diatasi dengan:

- Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
- Minum tablet tambah darah (TTD) 1 tablet per minggu sebelum hamil dan 1 tablet per hari selama kehamilan
- Mengobati jika ada penyakit penyerta yang menyebabkan Anemia



Jika catin perempuan mengalami Anemia, perlu segera mendapatkan penanganan kesehatan sampai Hb normal (> 12 mg/dL) dan menunda kehamilan dengan ber-KB



B. Kekurangan Gizi

Kondisi kurang gizi dalam keadaan terus menerus dapat mengakibatkan Kurang Energi Kronik (KEK). KEK adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. KEK merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia yang dialami oleh wanita usia subur termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Untuk mengetahui status KEK wanita usia subur adalah dengan cara mengukur lingkaran lengan atas (LiLA). Ambang batas LiLA pada WUS dengan KEK di Indonesia adalah 23,5 cm, artinya apabila LiLA kurang dari 23,5 cm, WUS mengalami KEK.

Ibu hamil dengan kekurangan gizi memiliki risiko yang dapat membahayakan ibu dan janin antara lain:

- Anemia pada ibu dan janin
- Perdarahan saat melahirkan
- Keguguran
- Mudah terkena penyakit infeksi
- Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- Bayi lahir mati
- Kelainan bawaan pada janin
- Stunting



Jika catin perempuan mengalami gizi kurang, sebaiknya menunda kehamilan dengan ber-KB dan mendapatkan penanganan kesehatan sampai status gizinya baik.

C. Infertilitas

Infertilitas adalah kondisi pada PUS, yang berhubungan seksual secara teratur (2-3 kali/minggu) dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi, yang belum pernah dan belum mampu mempunyai anak paling sedikit dalam kurun waktu 12 bulan (infertilitas primer). HIFERI, PERFITRI, IAUI, POGI. Konsensus Penanganan Infertilitas. Jakarta, 2013.

Faktor Risiko Infertilitas

Gaya hidup: merokok, gizi buruk, obesitas, defisiensi mikronutrien, konsumsi alkohol, stres dan olahraga berat, misalnya lebih dari 5 jam/minggu pada laki-laki atau 3-5 jam/minggu pada perempuan (yang dianjurkan 150 menit/minggu).

Konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat-obatan yang berpengaruh terhadap produksi testosteron dan sperma (misalnya spironolakton, sulfasalazin, kolkisin dan allopurinol, antibiotik tertentu, simetidin dan obat-obat herbal tertentu seperti ginkobiloba).

Keterpaparan terhadap suhu tinggi dan bahan berbahaya bagi fertilitas perempuan dan laki-laki, misalnya panas, radiasi sinar-X, logam dan pestisida.

Penyebab Infertilitas Pada Perempuan

- Gangguan ovulasi: dapat berupa gangguan siklus haid, yaitu amenore primer atau sekunder, oligomenorea dan sindrom ovarium polikistik.
- Gangguan tuba dan pelvis, yang dapat disebabkan oleh infeksi sistem reproduksi, terutama Chlamidia, gonore dan TB; endometriosis: ditemukan pada 25%-50% perempuan. Sekitar 30%-50% di antara penderitanya mengalami infertilitas, akibat perlekatan dan distorsi anatomi panggul.
- Gangguan uterus, termasuk mioma submukosum, polip endometrium dan leiomyoma.

Penyebab Infertilitas Pada Laki-laki

- Kelainan urogenital bawaan atau yang didapat.
- Infeksi saluran urogenital.
- Suhu skrotum yang meningkat (misalnya akibat adanya varikokel).
- Kelainan endokrin.
- Kelainan genetik.
- Faktor imunologi.
- Kelainan idiopatik, yang mungkin disebabkan oleh disrupsi endokrin karena polusi lingkungan, radikal bebas, atau kelainan genetik.

D.Hepatitis B

Hepatitis B merupakan penyakit menular berupa peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B. Virus Hepatitis B dapat ditularkan melalui darah atau cairan tubuh dari penderita yang terinfeksi, seperti cairan serebrospinal, cairan vagina dan cairan tubuh lainnya.

Apabila salah satu pasangan menderita Hepatitis B, akan dapat menularkan kepada pasangannya dan keturunannya.

Gejala:

Tidak khas dan sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadari dirinya telah terinfeksi. Gejala seringkali timbul dalam keadaan penyakit yang sudah lanjut seperti sirosis (penyakit liver) bahkan kanker hati, sehingga Hepatitis sering disebut sebagai silent killer atau penyakit mematikan. Gejala yang dapat timbul:

- Demam
- Mual dan muntah
- Kencing berwarna gelap seperti teh
- Mata dan kulit berwarna kuning

Faktor risiko penularan:

- 95% penularan berasal dari ibu hamil pengidap virus Hepatitis B ke bayi yang dikandung atau dilahirkan
- 3-5% penularan melalui:
 - Hubungan seksual tidak aman dengan pengidap Hepatitis B
 - Transfusi darah terkontaminasi virus Hepatitis B
 - Penggunaan jarum suntik bergantian yang terkontaminasi virus Hepatitis B

Pencegahan:

- Menghindari faktor risiko penularan Hepatitis B
- Imunisasi Hepatitis B yang diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan ke-0, 1 dan 6

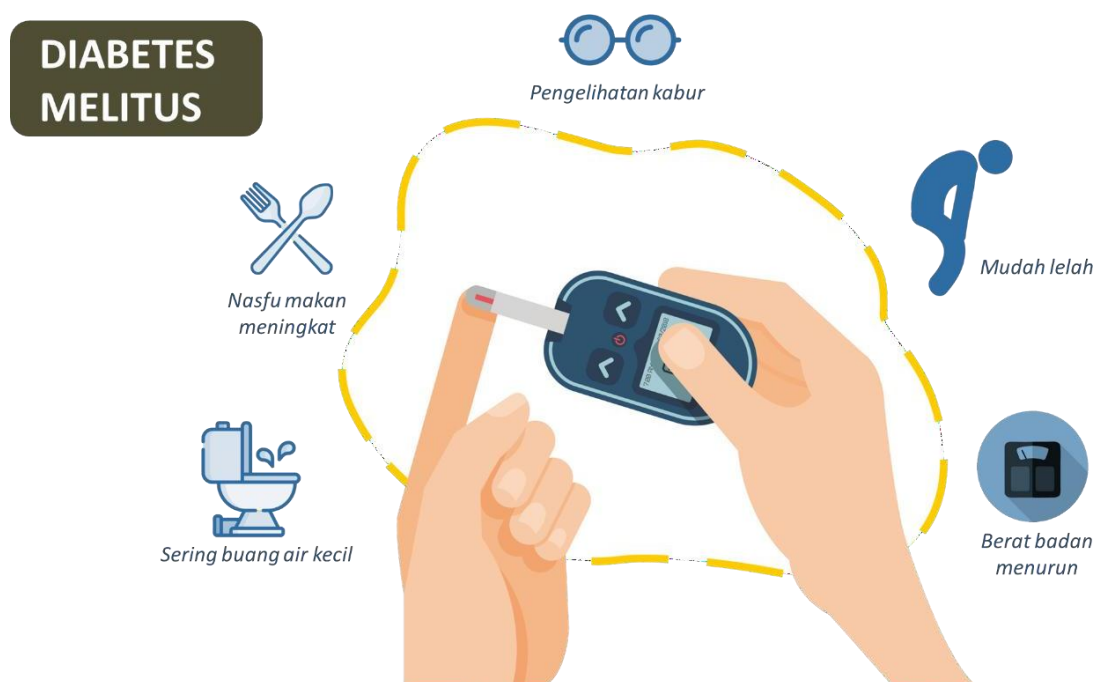
Bila sudah terdeteksi Hepatitis B:

- Segera konsultasi ke dokter
- Perlukaan pada kulit harus selalu dibalut
- Tidak berbagi peralatan mandi seperti pisau cukur, sikat gigi, sisir, gunting kuku dengan orang lain



E. Diabetes Melitus

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah ≥ 200 mg/dL (pada pemeriksaan gula darah sewaktu). DM disebabkan oleh kurangnya atau ketidakmampuan tubuh untuk memanfaatkan hormon insulin (insulin resistance). DM dapat memicu kerusakan berbagai organ lain dalam tubuh.



Gejala:

- Trias DM (banyak minum, banyak makan, sering kencing)
- Mudah lelah dan mengantuk
- Penglihatan kabur

- Penurunan berat badan meskipun nafsu makan mengalami peningkatan
- Bila terdapat luka lebih sulit sembuh
- Masalah pada kulit (misalnya gatal-gatal, iritasi dll)

Pencegahan:

Menjaga pola makan dengan gizi seimbang, melakukan aktifitas fisik dan periksa kesehatan secara rutin.

Dampak terhadap kehamilan:

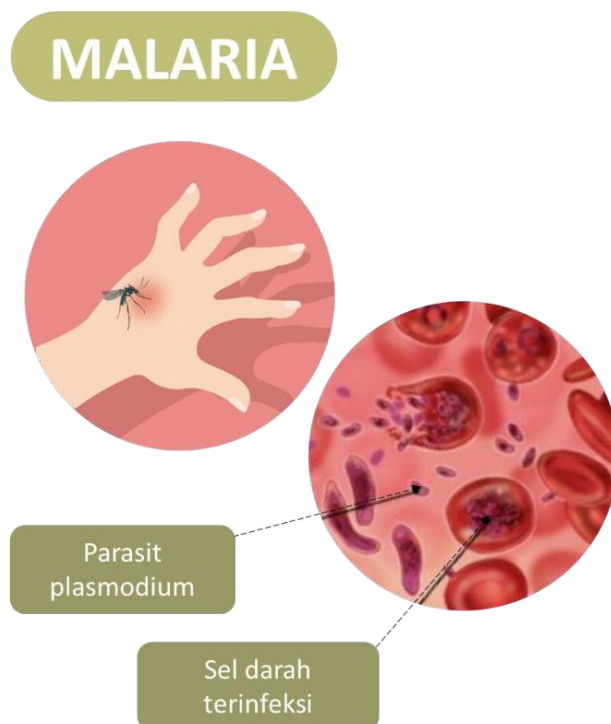
- Berat badan bayi lahir di atas normal/bayi lahir besar
- Bayi berisiko mengalami hiperbilirubinemia (kuning)
- Peningkatan risiko kelahiran prematur (lahir sebelum waktunya)
- Peningkatan risiko hipertensi dalam kehamilan
- Peningkatan risiko diabetes pada kehamilan berikutnya
- Bayi berisiko mengidap diabetes saat dewasa

Skrining Diabetes Melitus diperlukan untuk menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat.

F. Malaria

Indonesia mempunyai banyak daerah endemis Malaria. Penyakit ini disebabkan oleh sekelompok parasit Plasmodium yang hidup dalam sel darah merah yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Seseorang yang menderita Malaria dapat terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala.

Malaria bisa menyebabkan Anemia, dan pada catin perempuan kelak dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan keguguran, risiko perdarahan saat melahirkan, bayi lahir sebelum waktunya, dan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).



Pencegahan:

- Penggunaan kelambu saat tidur.
- Tutup pintu dan jendela menggunakan kawat/kasa/kelambu nilon.
- Gunakan pakaian pelindung yang menutupi lengan kaki saat keluar rumah.
- Gunakan obat/krim anti nyamuk.

G.TORCH

TORCH adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus (CMV), dan Herpes simplex virus II (HSV-II) serta virus lainnya.

Pencegahan:

- Vaksinasi MMR (Mumps Measles Rubella) untuk mencegah komponen Rubella dari TORCH dilakukan 3-6 bulan dari rencana hamil.
- Perilaku hidup bersih dan sehat cuci tangan pakai sabun, mencuci bahan makanan (sayuran, buah, dan lainnya) dengan air bersih yang mengalir, dan memasak makanan sampai matang sempurna.

Penularan:

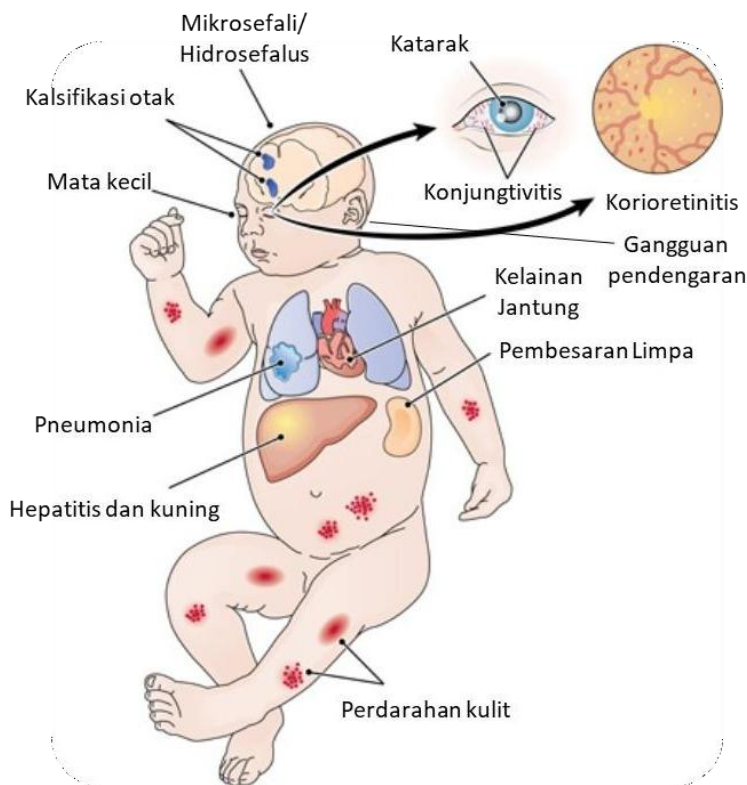
- Penularan aktif: konsumsi makanan dan sayuran yang terkontaminasi virus TORCH dan tidak dimasak sempurna. Makanan/sayuran dapat terkontaminasi virus TORCH dari kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, burung, dan lain-lain.
- Penularan pasif: dari ibu hamil pengidap TORCH ke janin.

Dampak:

- Infertilitas (baik catin perempuan maupun laki-laki)
- Kelak jika hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada janin, misal kelainan saraf, mata, telinga, otak (mikrosefali atau hidrofalus), kelainan paru-paru, limpa, terganggunya fungsi motorik, dll.

TORCH

***TOXOPLASMA, RUBELLA,
CYTOMEGALOVIRUS, HERPES***



Skrining Malaria dan TORCH diperlukan untuk menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat

H. Thalassemia

Thalassemia merupakan penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah mudah pecah, sehingga

penderita mengalami kurang darah berat yang dapat mengancam jiwa. Penyakit ini diturunkan oleh kedua orang tua pembawa sifat Thalassemia kepada anak kandung dan keturunannya.

Terdapat 2 jenis Thalassemia yaitu Thalassemia Minor dan Thalassemia Mayor. Orang dengan Thalassemia Minor/ pembawa sifat tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala. Sedangkan orang dengan Thalassemia Mayor memerlukan pengobatan dan transfusi darah rutin seumur hidup serta memiliki usia harapan hidup yang relatif pendek.

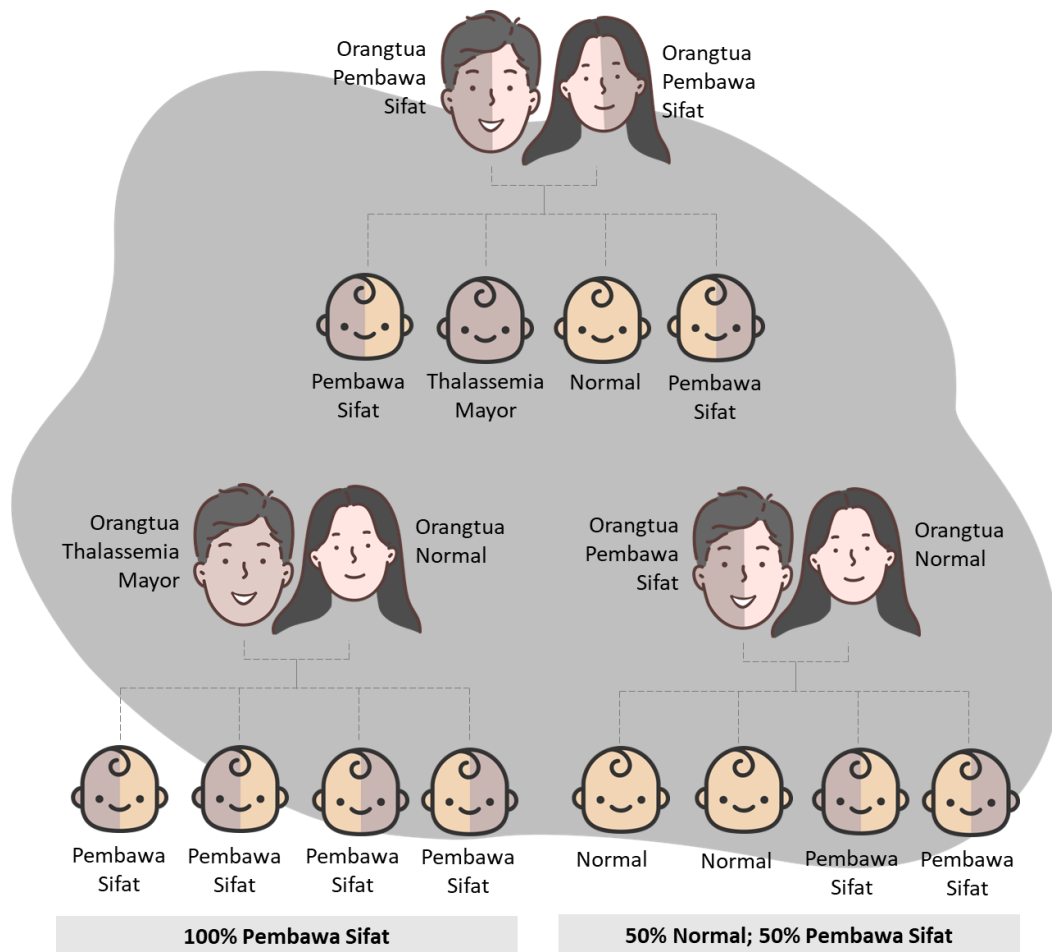
Pencegahan:

Untuk mencegah kelahiran anak dengan Thalassemia Mayor dilakukan melalui:

- Skrining Thalassemia sedini mungkin atau sebelum menikah pada calon laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan calon merupakan pembawa sifat Thalassemia.
- Jika kedua pasangan calon pembawa sifat Thalassemia memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan untuk menghindari kehamilan dengan selalu menggunakan

kontrasepsi, karena jika hamil berisiko melahirkan anak dengan Thalassemia Mayor.

THALASSEMIA



Deteksi dini:

- Memiliki keluarga dengan riwayat penyakit Anemia atau Thalassemia.
- Pucat dan lemah.

- Riwayat transfusi berulang
- Pemeriksaan darah dan analisis Hb

Pasangan pembawa sifat Thalassemia berisiko menurunkan penyakit Thalassemia kepada anak kandung dan keturunannya.

Orang dengan Thalassemia minor/pembawa sifat tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala

I. Hemofilia

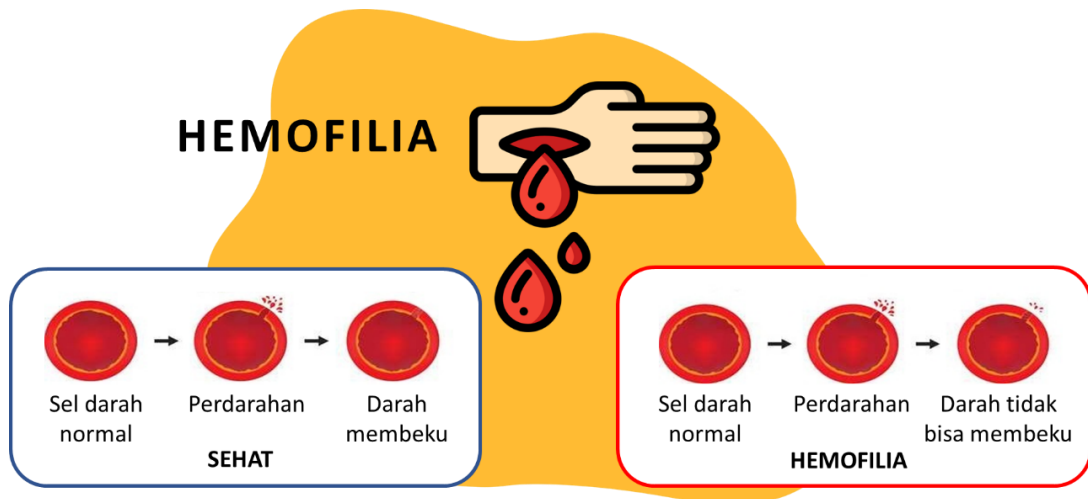
Hemofilia adalah penyakit/gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama dan umumnya dialami oleh laki laki.

Penyakit ini diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tua kepada anak kandung dan keturunannya. Laki-laki lebih berisiko menderita Hemofilia dengan gejala ringan hingga berat, sedangkan perempuan hanya sebagai pembawa sifat.

Gejala:

- Perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama misal pada luka, cedera, operasi, cabut gigi, pasca suntikan, dan pasca imunisasi suntik. Tingkat keparahan tergantung dari jumlah faktor pembekuan di dalam darah.

- Mudah memar pada kulit bila terbentur, persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit kepala, cepat lelah, dan penglihatan ganda.



Apabila salah satu pasangan adalah penderita atau pembawa sifat Hemofilia, maka **berisiko menurunkan penyakit Hemofilia kepada anak kandung dan keturunannya.**

Orang dengan Hemofilia tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala

Pencegahan:

Untuk mencegah risiko kelahiran anak dengan Hemofilia dilakukan:

- Skrining Hemofilia sedini mungkin atau sebelum menikah pada catin laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan catin merupakan pembawa sifat atau penderita Hemofilia. Jika salah satu catin merupakan pembawa sifat atau penderita Hemofilia memutuskan untuk tetap menikah dan

- Mempunyai anak, akan berisiko melahirkan anak laki- laki dengan Hemofia atau anak perempuan pembawa sifat Hemofilia.
- Penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan.

J. Infeksi Menular Seksual (IMS)

IMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual.

Gejala IMS:

- Adanya duh tubuh/cairan yang keluar dari alat kelamin (vagina, penis) atau cairan dari anus, yang berbeda dari biasanya.
- Rasa perih atau nyeri atau panas pada saat kencing atau setelah kencing, atau menjadi sering kencing.
- Ada luka terbuka/basah di sekitar kelamin atau sekitar mulut. Luka ini bisa terasa nyeri bisa juga tidak.
- Ada semacam jaringan yang tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar kelamin.
- Terjadi pembengkakan pada lipatan paha.
- Pada laki-laki, terdapat bengkak dan nyeri pada kantung pelir kantung zakar.
- Sakit perut di bagian bawah yang kambuhan, tetapi tidak berhubungan dengan haid/menstruasi.

- Keluar darah setelah berhubungan seksual.
- Demam

Jenis-jenis IMS

1. Gonore (Kencing Nanah)



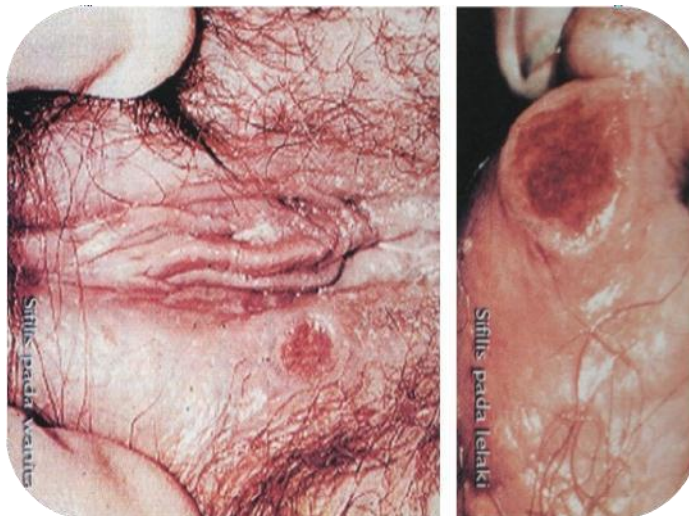
Gejala:

- Pada laki-laki: keluarnya cairan dari alat kelamin, bernanah, kental, berwarna putih kekuningan.
- Pada perempuan: seringkali tanpa gejala, bila ada berupa cairan dari alat kelamin berwarna putih atau kuning. Cairan terutama akan banyak terlihat di daerah mulut rahim melalui pemeriksaan dalam oleh tenaga kesehatan.

Komplikasi:

- Pada laki-laki menyebabkan kemandulan.
- Pada perempuan menyebabkan mandul dan kehamilan di luar rahim/ektopik.
- Pada bayi baru lahir dari perempuan dengan Gonore, menyebabkan Konjungtivitis Gonore yaitu berupa kemerahan pada salah satu atau kedua mata dengan adanya cairan yang keluar dari mata dengan nanah dan mengakibatkan kebutaan.

2. Sifilis (Raja Singa)



Gejala:

- Luka atau koreng, biasanya berjumlah satu, berbentuk bulat atau lonjong, dasar bersih dan bila diraba terasa kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri bila ditekan.

- Kelenjar getah bening di lipat paha bagian dalam membesar, kenyal, juga tidak nyeri bila ditekan.

Komplikasi:

- Perempuan penderita sifilis dapat mengalami keguguran, melahirkan bayi cacat atau lahir dalam keadaan sudah mati.

3. Herpes Genitalis



Gejala:

- Herpes genital pertama: timbul bintil-lentingan-luka berkelompok,
- di atas dasar kemerahan, sangat nyeri, pembesaran kelenjar lipat paha, kenyal dan disertai gejala yang menyeluruh dan saling berhubungan (sistemik).

- Herpes genital kambuhan: timbul bila ada faktor stres pikiran, hubungan seksual berlebihan, kelelahan dan lain- lain. Umumnya luka/lesi tidak sebanyak dan seberat gejala pertama.

Komplikasi:

Dapat menjadi pintu masuk infeksi lain dan bersifat kambuhan seumur hidup.

4. Klamidia

(gambar Klamidia/tidak ada gambarnya)

Gejala:

- Pada laki-laki: keluarnya cairan dari alat kelamin, bernanah, encer kadang kental, berwarna putih kekuningan, dapat disertai peradangan pada kulit alat kelamin.
- Pada perempuan: keluarnya cairan dari alat kelamin, bernanah encer, berwarna putih atau kuning, leher rahim mudah berdarah.

Komplikasi:

- Pada laki-laki menyebabkan kemandulan.
- Pada perempuan menyebabkan kehamilan di luar kandungan/ektopik dan kemandulan.

- Pada bayi baru lahir dari perempuan dengan Klamidia, menyebabkan Konjungtivitis Klamidiosis yaitu berupa sembab, kemerahan pada salah satu atau kedua mata dengan adanya cairan yang keluar dari mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak dan dapat menimbulkan kebutaan.

5. Kondilomata Akuminata (Jengger Ayam)



Gejala:

Bintil-bintil tonjolan berbentuk seperti kutil terutama pada daerah yang lembab. Bersifat kambuhan seumur hidup.

Komplikasi:

- Dapat membesar dan tumbuh menjadi satu.
- Pada laki-laki dapat menimbulkan kanker penis.

- Pada wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim.

Pencegahan Terinfeksi IMS

1. Jaga kebersihan kelamin
2. Tidak berhubungan seksual
3. Menggunakan kondom
4. Setia pada pasangan
5. faktor pencetus
6. Bila ada gejala, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan dan minum obat sesuai anjuran

Tindakan Jika Terinfeksi IMS

1. Jangan mengobati sendiri.
2. Segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Minum obat teratur dan sampai tuntas sesuai petunjuk dokter.
4. Jangan berhubungan seksual sampai IMS sembuh.
5. Minta pasangan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah dan mengetahui adanya penularan.

IMS: Gerbang menuju HIV AIDS

Tidak semua IMS dapat diobati. HIV AIDS, Hepatitis B & C, Herpes Genitalis dan Kondiloma Akuminata (Jengger Ayam) termasuk jenis-jenis IMS yang tidak dapat di sembuhkan.

HIV adalah yang paling berbahaya karena selain tidak dapat disembuhkan, HIV merusak kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakitapun. Akibatnya, orang dengan HIV rentan tertular penaki, walaupun dengan penyakit infeksi ringan dapat menimbulkan dampak yang parah hingga mengakibatkan kematian. HIV akan lebih mudah menulara pada penderita IMS.

Hepatitis, merupakan peradangan hati yang dapat merusak hingga hati tidak dapat berfungsi dengan baik. Hepatitis B dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi vaksin Hepatitis C hingga kini belum ada.

Herpes Genitalis, sering kambuh dan sangat nyeri jika sedang kambuh. Pada Herpes, yang dapat diobati hanya gejala luarnya saja, tetapi bibit penyakitnya akan tetap hidup dalam tubuh penderita selamanya.

Kondilomata Akumilata/ Jengger Ayam, pada laki-laki dapat menyebabkan kanker penis sedangkan pada perempuan seringkali menyebabkan kanker rahim.

Hubungan seksual yang aman,
bertanggung jawab dan
dengan pasangan yang sah
adalah cara menghindari IMS



K. HIV-AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus merupakan kuman/virus penyebab AIDS.

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang di dapat dari infeksi HIV.

Infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia.

Beberapa cara yang beresiko menularkan HIV diantaranya:

- Hubungan seksual tidak aman. Pada saat berhubungan seksual tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi, cairan mani/sperma atau cairan vagina langsung ke aliran dara pasangannya, atau melalui selaput lendir yang berada dibagian dalam vagina, penis atau dubur.

- HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau melalui alat tindakan medis lain yang tercemar HIV.
- Penggunaan jarum suntik bersama/bergantian pada pecandu narkoba suntik berisiko tertular HIV.
- HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui (penularan HIV dari ibu ke anak).

HIV tidak menular melalui:

- Makan/minum bersama, memakai peralatan makan minum mereka.
- Bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan.
- Hidup serumah, menggunakan WC/toilet bersama, berenang bersama.
- Bergantian pakaian, handuk, saputangan.
- Hubungan sosial lainnya.
- Gigitan serangga

Gejala HIV:

- Setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja seperti halnya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi orang tersebut bisa menularkan virus HIV

melalui penularan cairan tubuh (darah, cairan sperma, cairan vagina, ASI). Hal ini bisa terjadi selama 5-10 tahun.

- Setelah itu orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV.

Pencegahan HIV AIDS:

1. Tidak berhubungan seksual

Tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko.

2. Saling Setia

Masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

3. Kondom

Gunakan kondom secara benar setiap kali berhubungan seksual apabila salah satu pasangan ada yang menderita HIV positif atau status HIV pasangan belum diketahui.

4. Hindari penggunaan narkoba suntik

Menggunakan jarum bergantian berisiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah, namun apapun bentuknya, hindari NARKOBA karena hanya akan merugikan diri sendiri.

5. Penggunaan alat-alat yang steril

Jangan gunakan jarum, alat suntik, atau alat peluka (alat penembus) kulit lainnya (tindik atau tato) secara bergantian. Penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah.

6. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)

- a. Apabila salah satu/kedua pasangan mempunyai faktor risiko maka lakukan tes HIV.
- b. Jika salah satu/kedua pasangan mengidap HIV, minum obat ARV sesuai anjuran secara teratur seumur hidup.
- c. Pasangan ODHA harus minum obat ARV dan selalu menggunakan kondom setiap berhubungan seksual.
- d. Jika pasangan ODHA ingin memiliki anak, konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk merencanakan waktu yang tepat untuk hamil sesuai dengan status kesehatan pasangan.
- e. Lakukan tes HIV pada saat pemeriksaan kehamilan trimester 1, dan berikan ARV profilaksis pada bayi dari ibu HIV.

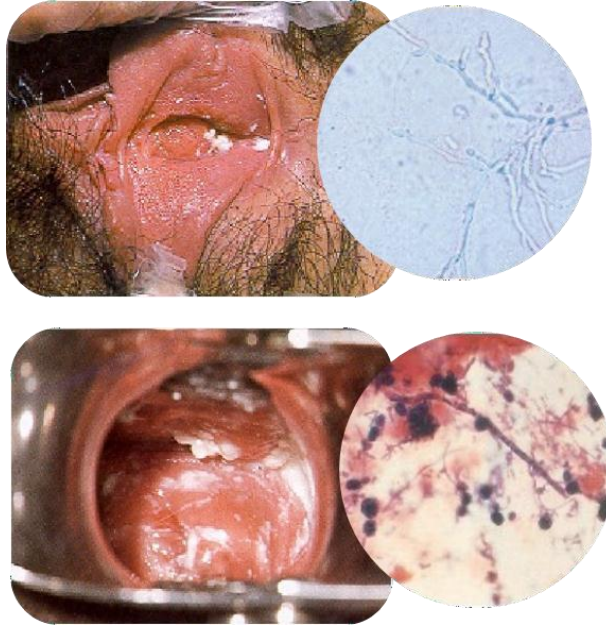
L. Infeksi Saluran Reproduksi (ISR)

ISR adalah masuk dan berkembangbiaknya kuman penyebab infeksi ke dalam saluran reproduksi.

ISR dapat ditularkan tanpa hubungan seksual.

Jenis-jenis ISR:

1. Kandidiasis Vaginalis



Gejala:

- Gatal pada kelamin, kemerahan dan peradangan pada bibir vagina dan lang vagina, disertai bengkak atau luka sobekan kecil.
- Keluarnya cairan yang banyak serta bergumpal dari vagina, kadang-kadang dapat kental, berwarna putih seperti susu kental atau kekuningan dan berbau asam.

Komplikasi:

Lecet pada kult di sektar kelamin.

Pencegahan:

- Jaga kebersihan alat kelamin.

- Pakaian dalam tetap bersih dan kering

2. Vaginosis Bakterial



Gejala:

Vagina berbau amis terutama setelah berhubungan seksual, keluarnya cairan dari vagina namun tidak terlalu banyak, berwarna putih keabu-abuan, melekat pada dinding vagina, tidak ada tanda-tanda peradangan.

Komplikasi:

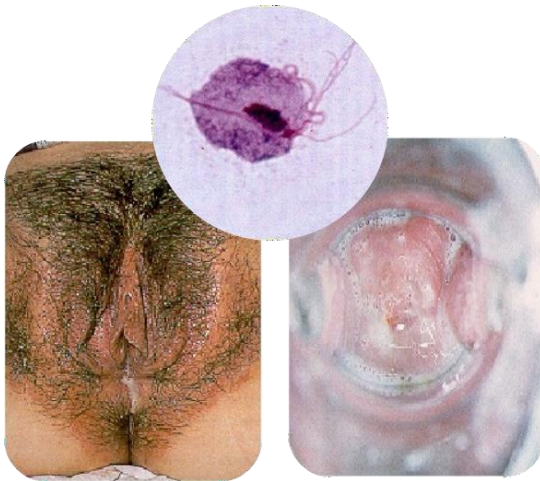
Menyebabkan penyakit radang panggul dan pada ibu hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah.

Pencegahan:

- Jaga kebersihan alat kelamin
- Tidak berhubungan seksual

- Menggunakan kondom
- Setia pada pasangan

3. Trikomoniasis



Gejala:

keluarnya cairan yang banyak dari vagina, bemanah, kadang-kadang berbusa, peradangan pada vagina, berbau seperti kan busuk, dapat disertai rasa gatal pada alat kelamin.

Komplikasi:

Pada ibu hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur dan bayi berat badan lahir rendah.

Pencegahan:

- Jaga kebersihan alat kelamin
- Tidak berhubungan seksual
- Menggunakan kondom
- Setia pada pasangan

BAB 5

KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM

A. Kanker Payudara

Kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara.

Faktor risiko:

- Merokok atau terpapar asap rokok
- Ibu atau saudara ibu/klien yang memiliki kanker payudara
- Menopause (berhenti haid) >50 tahun
- Menstruasi pertama kali sebelum usia 12 tahun
- Tidak memiliki anak/ infertilitas
- Melahirkan anak pertama setelah usia 35 tahun
- Tidak pernah menyusui
- Riwayat adanya penyakit tumor jinak payudara
- Adanya riwayat penyakit kanker pada anggota keluarga lainnya

- Diet dan faktor yang berhubungan dengan diet (peningkatan berat badan/obesitas, pola makan yang buruk tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet/ pewarna, minuman beralkohol)

Tanda-tanda:

- Penambahan ukuran/besar yang tak biasa pada payudara
- Salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya
- Lekukan seperti lesung pipit pada kulit payudara
- Pembengkakan pada lengan bagian atas
- Perubahan penampilan puting payudara
- Keluar cairan seperti susu atau darah dari salah satu puting
- Benjolan pada payudara
- Pembesaran kelenjar getah bening pada lipat ketiak (axilla)

Deteksi dini:

- **SADARI** (pemerikSAan payuDARA sendiRI), yang dilakukan pada hari ke 7-10 di hitung mulai dari hari pertama haid, atau bagi yang telah menopause atau tidak haid karena menggunakan KB dilakukan rutin setiap bulan pada tanggal yang sama.

- **SADANIS** (pemerikSAan payuDARA kliNIS) oleh tenaga kesehatan yaitu dokter/bidan, sebaiknya dilakukan 1 tahun/ kali, minimal 3-5 tahun sekali atau bila terdapat kelainan pada saat melakukan SADARI.

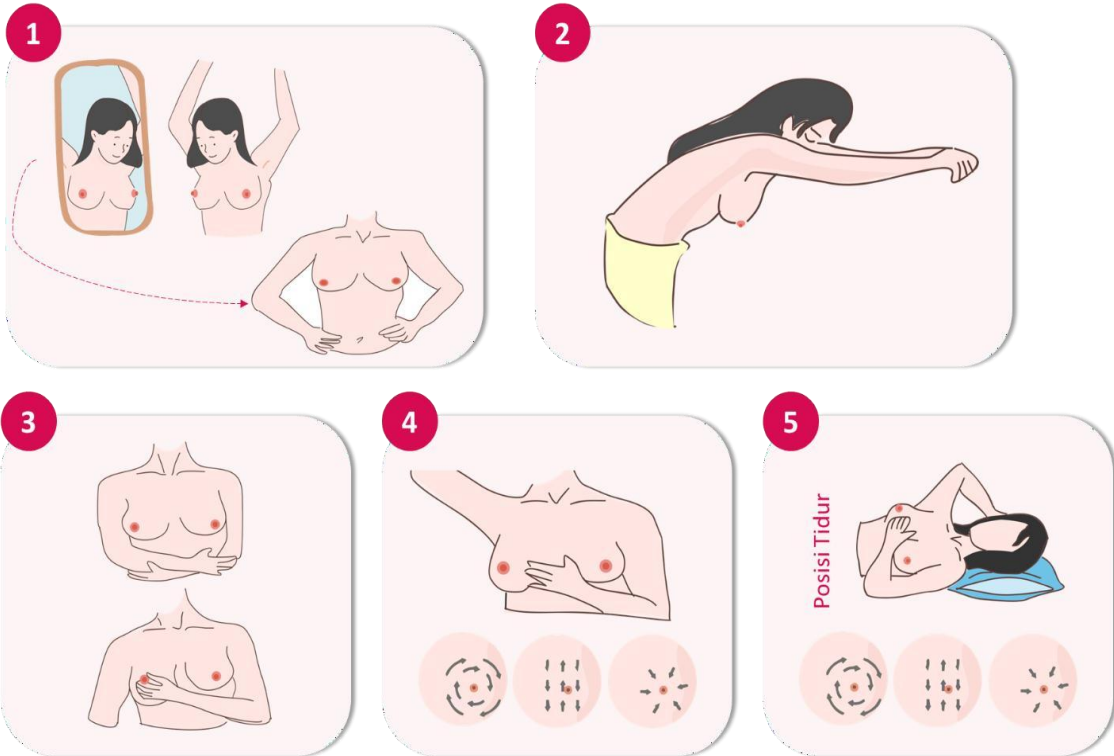
- **PEMERIKSAAN Ultrasonography (USG)**

USG dilakukan terutama untuk membuktikan adanya massa kistik dan solid/padat yang mengarah pada keganasan, dan pada perempuan dibawah usia 40 tahun.

- **Pemeriksaan Skrining Mammografi**

Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, yaitu pada perempuan usia 40 – 50 tahun setiap 2 tahun sekali dan setiap tahun 1 kali pada perempuan di atas 50 tahun kecuali yang mempunyai faktor risiko.

SADARI (PERIKSA PAYUDARA SENDIRI)



Langkah 1:

Mulai dengan melihat payudara anda di cermin dengan posisi kedua lengan di samping tubuh. Kemudian angkat kedua tangan ke atas dan perhatikan apakah ada perubahan pada payudara.

Anda harus melihat:

- Perubahan payudara dari ukuran, bentuk, dan warna kulit atau ada kerutan pada kulit (kulit jeruk) atau ada cekungan/ada tarikan kulit ke dalam.

- Letakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi dan perhatikan apakah terjadi perubahan pada payudara.

Jika anda melihat perubahan berikut ini, segera anda kedokter untuk berkonsultasi:

- Perubahan ukuran dan bentuk payudara.
- Kulit payudara mengeras, mengelupas, mengerut seperti kulit jeruk, atau terdapat cekungan seperti lesung pipit.
- Perubahan pada puting, seperti puting tertarik kedalam atau keluar cairan dari puting.
- Benjolan/kelainan lainnya dari payudara.
- Kemerahan, nyeri, ruam-ruam, atau bengkak.

Langkah 2:

Kemudian bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang.

Langkah 3:

Kemudian, dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring, bila dalam keadaan berbaring sebaiknya letakkan sebuah bantal di bawah pundak sisi payudara yang akan dipriksa.

Langkah 4:

Angkat salah satu lengan ke atas dan tekuk siku sehingga tangan memegang bagian atas punggung/kepala, kemudian dengan menggunakan permukaan jari tangan yang lain raba dan tekan payudara dengan gerakan melingkar dimulai dari bagian luar yaitu tepi payudara sampai ke bagian dalam yaitu putting, selanjutnya cubit areola putting apakah keluar cairan atau tidak, cermati seluruh bagian payudara kiri hingga ke daerah ketiak. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan.

Langkah 5:

Dalam posisi berbaring tekuk salah satu siku sehingga tangan menyentuh kepala belakang. Kemudian dengan tangan yang lain rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, dari atas sampai bawah, kiri kanan, dari tulang pundak.

Lakukan SADARI secara rutin pada hari ke 7-10 dari hari pertama haid.

B. Kanker Leher Rahim

Kanker Leher Rahim adalah keganasan yang terjadi dan berasal dari sel leher rahim.

KANKER LEHER RAHIM (SERVIKS)

PENYEBAB DAN FAKTOR RISIKO



Pencegahan:

Pencegahan primer kanker leher rahim dilakukan melalui imunisasi HPV secara mandiri.

Deteksi dini:

- Deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30 – 50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan bisa dilakukan setiap tahun, minimal 3-5 tahun sekali

- Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan Tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) dan Pap Smear.
- Perbedaan IVA dan Pap Smear antara lain:
 - Hasil tes IVA dapat segera diketahui 1 menit setelah dioles asam asetat sedangkan Pap smear membutuhkan waktu 1-2 minggu kemudian.
 - Tes IVA dapat dilakukan kapan saja kecuali dalam keadaan hamil atau haid yang banyak
 - Biaya pemeriksaan tes IVA lebih murah dibandingkan dengan Pap Smear.
- Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan di Dokter/Bidan, Puskesmas, Klinik swasta, Rumah Sakit.
- Pada stadium awal umumnya kanker leher rahim tidak memiliki gejala. Pada stadium lanjut, gejalanya antara lain:
 - Pendarahan pasca hubungan seksual
 - Perdarahan tidak normal dari vagina bercak-bercak hingga menggumpal disertai bau busuk
 - Keputihan berbau busuk
 - Nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar

BAB 6

KEHIDUPAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

Kehidupan seksual suami dan istri adalah suatu hubungan yang dibina oleh suami dan istri, dimana masing-masing pihak dapat memperlihatkan bentuk kasih sayang cintanya lewat sebuah tindakan pribadi yang dilakukan berdua.

Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Fungsi seksual akan baik jika kedua faktor tersebut baik. Faktor fisik antara lain: ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain: ada tidaknya stress, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis atau kadar cinta dengan pasangan.

Komunikasi apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pasangan. Kehidupan seksual dalam rumah tangga tidak boleh berpihak hanya kepada satu orang saja, tetapi harus dapat dikomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, sehingga ketika kegiatan seksual itu dilaksanakan, pihak suami atau istri itu sama-sama mengetahui apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak dapat menikmati kehidupan seksual yang sehat dan berkualitas.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual terutama bagi mereka yang menikah dan telah hidup bersama setiap hari. Namun ada kalanya dorongan seksual tersebut terganggu oleh beberapa hal. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada istri (perempuan) ataupun suami (laki-laki).

A. Gangguan Seksual Pada Perempuan

Gangguan seksual yang sering di temukan pada perempuan antara lain:

- Gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif (frigid) atau hiperaktif (nymphomania).
- Gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang.
- Rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual.
- Tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual.

B. Gangguan seksual pada Laki-laki

Gangguan seksual yang sering ditemukan pada laki-laki antara lain:

- Gangguan dengan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif (frigid) atau hiperaktif (ninfomania).
- Disfungsi ereksi (impotensi), hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik misalnya karena menderita diabetes mellitus atau faktor psikis misalnya karena stress.
- Gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat.
- Gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme.

C. Mencegah Gangguan Seksual

- selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan.
- Bersikap dan bicaralah secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang tidak mereka suka.
- Jaga kesehatan tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa yang sehat menjadi faktor pendukung untuk membangkitkan gairah dari masing-masing pasangan.

- Hindari gaya hidup tak sehat, misalnya rokok, stress, kurang tidur, pola makan tidak baik, dan tidak berolahraga. Stamina akan berkurang sehingga akan cepat lelah, akibatnya, keinginan untuk melakukan hubungan seksual akan berkurang.
- Jangan mengonsumsi obat/ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Meminum obat yang tidak diketahui efek sampingnya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal.
- Jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rileksasi
- Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan.
- Jangan melakukan hubungan seksual sebagai hal yang rutin.

BAB 7

Menjaga Kesehatan Jiwa dan Harmonisasi Pasangan Suami Istri

Sehat jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Ciri-ciri sehat jiwa:

- Perasaan sehat dan bahagia
- Menyadari kemampuan diri
- Merasa nyaman terhadap diri sendiri
- Dapat menerima orang lain apa adanya
- Merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain
- Mampu memenuhi kebutuhan hidup
- Mampu menghadapi tantangan hidup
- Mempunyai sikap positif terhadap diri dan orang lain
- Untuk menjaga harmonisasi pasangan suami istri setiap catin perlu mengenali karakteristik dari masing-masing pasangan.

Karakteristik pasangan suami istri yang baik:

- Mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama.
- Saling mengerti, menghormati, menghargai, dan menutupi kekurangan masing-masing pasangan kepada orang lain.
- Bersama-sama menjaga kesehatan keluarga.



Saling mengenali dan memahami karakter pasangan penting untuk mewujudkan keluarga yang **sehat, bahagia dan sejahtera**

BAB 8

KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

A. Saling Menghormati dan Menghargai

Pernikahan yang ideal dapat terjadi ketika suami dan istri saling menghormati dan menghargai satu sama lain, misalnya:

- Pengambilan keputusan di rumah tangga dilakukan secara bersama dan tidak memaksakan ego masing-masing.
- Suami istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan, dan pendidikan anak.
- Perencanaan kehamilan dan keikutsertaan ber-KB merupakan keputusan dan tanggung jawab bersama suami dan istri.
- Suami memberikan dukungan selama proses kehamilan, melahirkan, dan pengasuhan anak
- Suami mendukung pelaksanaan ASI eksklusif.

B. Tindak Kekerasan yang Mengganggu Pernikahan

Hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah:

- **Kekerasan secara fisik** (misal: memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, melukai)
- **Kekerasan secara psikis** (misal: menghina, mengeluarkan komentar yang merendahkan, melarang pasangan mengunjungi saudara atau teman, mengancam)
- **Kekerasan seksual** (misal: memaksa dan menuntut berhubungan seksual, melakukan hubungan seksual yang tidak aman)
- **Penelantaran** (misal: tidak memberi nafkah lahir/batin, melarang pasangan bekerja)
- **Eksplorasi** (misal: memanfaatkan, memperdagangkan dan memperbudak pasangan)



C. Solusi Mengatasi Tindak Kekerasan

Apabila terjadi tindak kekerasan, maka sebaiknya suami maupun istri berupaya mencari solusi lebih dahulu dengan cara berdialog atau mencari bantuan/mediasi dengan menceritakan kejadian kepada orangtua, teman dekat atau kerabat yang terpercaya.

Langkah-langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah:

- Mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) untuk mendapatkan penanganan pada luka fisik maupun psikis, dan atau rujukan.

- Melapor ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- Melapor ke polisi (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/UPPA) dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik.
- Mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), psikolog atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

BAB 9

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakanyang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan:

GERMAS bertujuan agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada:

- Kesehatan terjaga
- Produktif
- Lingkungan bersih
- Biaya untuk obat berkurang

Pelaksanaan GERMAS melalui:

- Melakukan aktivitas fisik
- Konsumsi gizi seimbang

- Tidak merokok
- Tidak mengonsumsi alcohol
- Mengelola stress
- Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Memeriksa kesehatan secara berkala

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)



Catin harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan keluarga sehat berkualitas

KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN

Pengarah:

Direktur Kesehatan Keluarga

Editor:

Subdirektorat Kesehatan
Usia Reproduksi, Direktorat
Kesehatan keluarga

Kontributor:

- Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal, Direktorat Kesehatan Keluarga
- Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga
- Subdirektorat Pengelolaan Konsumsi Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
- Subdirektorat Penanggulangan Masalah Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
- Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- Subdirektorat Imunisasi, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
- Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- Subdirektorat Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- Subdirektorat HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- Subdirektorat Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

